Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes

Recommandations de bonne pratique 2019

Jeu de diapositives réalisé par le comité des référentiels de la SPILF

16/10/2019

Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes
Messages clés

- Ces recommandations pour la prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes s'adressent prioritairement aux médecins de ville (généralistes, pédiatres, dermatologues).
- Le terme « érysipèle », correspondant à une dermo-hypodermite non nécrosante d’origine streptococcique, n’est plus utilisé.
- **La durée totale de l'antibiothérapie** en ambulatoire de **7 jours** au maximum

Dermo-hypodermites bactériennes (DHB)

- Le diagnostic est clinique.
  - Apparition brutale d'un placard inflammatoire bien circonscrit associé à une fièvre
  - Rechercher une porte d'entrée cutanée loco-régionale (intertrigo interorteils,…)
- Délimiter au feutre les contours du placard inflammatoire ou réaliser une photographie.

DHB

- Recherche de signes de gravité
  - Troubles de conscience, fréquence respiratoire ≥ 22/minute et PAS ≤ 100mmHg
  - Signes toxiques (voir définition diapositive suivante)
  - Extension rapide des signes locaux en quelques heures
  - Douleur très intense, impotence fonctionnelle
  - Autres signes locaux: lividités, taches cyaniques, crépitation sous-cutanée, hypo- ou anesthésie locale, induration dépassant l'érythème, nécrose locale,
  - Aggravation des signes locaux dans les 24 h à 48 h malgré l'instauration d'une antibiothérapie adaptée

Dermo-hypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN)

- En l'absence de signes de gravité, pas d'examens complémentaires
- Etiologie microbienne
  - Adulte → *Streptococcus pyogenes*
  - Enfant → *Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus*
- Complications
  - Récidive (20 à 30% des cas)
  - Abcédation
  - Décompensation des comorbidités
  - Sepsis, choc septique, choc toxinique, bactériémie (très rares)

Dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes (DHBN)

- En présence de signes de gravité, hospitalisation immédiate car il s’agit d’une urgence médico-chirurgicale avec mise en jeu du pronostic vital

DHB

- **Diagnostic différentiel**
  - Poussée inflammatoire d'insuffisance veineuse : si atteinte des membres inférieurs, bilatérale et sans fièvre
- **Formes particulières**
  - Staphylococcie « maligne » de la face : si localisation faciale et signes généraux importants
  - Gangrène de Fournier : si localisation périnéale et sepsis

DHBNN

- **Critères d'hospitalisation:**
  - En urgence si
    - Si signes de gravité locaux ou généraux
    - Risque de décompensation d'une comorbidité
    - Obésité morbide (IMC > 40)
    - Sujet âgé > 75 ans poly-pathologique
    - Age inférieur à un an
    - Risque de non-observance thérapeutique
  - Secondairement si
    - Evolution défavorable dans les 24 à 48h après l'instauration de l'antibiothérapie

DHBNN

- **Traitement**
  - Antibiothérapie orale : pendant 7 jours (voir tableau)
  - **Pas** d'antibiothérapie locale
  - **Pas** de corticoïdes ni d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
  - Si atteinte d'un membre : repos avec surélévation du membre atteint
  - Contention veineuse dès l'amélioration de la douleur
  - Vérification du statut vaccinal antitétanique
  - En prévention des récidives
    - Prise en charge des facteurs de risque (lymphœdème, porte d'entrée, obésité)
    - Antibioprophylaxie à discuter si facteurs de risque non contrôlables et après 2 épisodes dans l'année écoulée (uniquement chez l'adulte): durée en fonction de l'évolution des facteurs de risque de récidive (voir tableau)

DHBNN

- Traitement curatif/Prévention antibiotique des récidives

Pathologie	Traitement antibiotique 1° intention	Si allergie à la Pénicilline	Durée
DHBNN adulte	amoxicilline : 50 mg/kg/j en 3 prises, maximum 6 g/j	Pristinamycine : 1g x 3/j ou Clindamycine : 600 mg x 3/j, jusqu'à 600 mg x 4/j (P >100 kg)	7 jours
DHBNN enfant	amoxicilline-acide clavulanique : 80 mg/kg/j d'amoxicilline en 3 prises/j (maximum 3g/j)	Clindamycine : 40 mg/kg/j en 3 prises/j (enfants > 6 ans) Sulfaméthoxazole-triméthoprime : 30 mg/kg/j (exprimé en sulfaméthoxazole) en 3 prises/j (forme suspension buvable pour enfants < 6 ans)	7 jours
DHBNN adulte Antibioprophylaxie	Benzathine-benzyl-pénicilline G (retard) : 2,4 MUI IM toutes les 2 à 4 semaines Pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline): 1 à 2 millions UI/j selon le poids en 2 prises	Azithromycine : 250 mg/j	A évaluer : en fonction de l'évolution et des facteurs de risque de récidive.

INFECTION BACTERIENNE DES PLAIES CHRONIQUES

- **Suspicion d'infection de plaie chronique**, en cas d'association de plusieurs signes suivants :
  - une douleur inhabituelle au niveau ou en périphérie de la plaie,
  - un arrêt de la cicatrisation, un tissu de granulation friable,
  - l'aggravation de la plaie (augmentation rapide de la taille, de l'exsudat, caractère purulent ou nécrotique)
  - des signes généraux d'infection
- Pas de prélèvement bactériologique systématique
  - Sauf si suppuration franche ou abcédation : prélèvement du pus avant antibiothérapie
  - Soins locaux, pas d'antibiotiques, avis spécialisé
- Si dermo-hypodermite ou abcès associés : voir chapitres correspondants

FURONCLES ET ANTHRAX

- **Définition :** infection profonde et nécrosante du follicule pilo-sébacé due à *Staphylococcus aureus* (SA).

- **Formes compliquées de furoncle**
  - Conglomérat de furoncles : anthrax
  - Multiplication des lésions
  - Abcédation secondaire
  - Fièvre
  - Apparition d’une dermo-hypodermite péri-lésionnelle

FURONCLES ET ANTHRAX

- **Diagnostic et bilan**
  - **Clinique**: lésion papulo-nodulaire très inflammatoire évoluant en 5 à 10 jours vers la nécrose folliculaire avec l'élimination du follicule pileux (bourbillon).
  - **Furoncle simple** : pas de prélèvement bactériologique
  - **Furoncle compliqué** : prélèvement bactériologique du pus avant antibiothérapie, pas de recherche systématique de la Leucocidine de Panton-Valentine (LPV)

Traitement du furoncle simple

- Soins locaux uniquement
  - Pas de manipulation du furoncle (limite le risque de complications)
  - Soins de toilette quotidiens (lavage à l'eau et au savon)
  - Incision de l'extrémité pour évacuer le bourbillon (furoncle volumineux)
  - Protection de la lésion avec un pansement
- Pas d'antibiothérapie (locale ou générale)

TRAITEMENT DU FURONCLE COMPLIQUE

- Antibiothérapie orale pendant 5j : clindamycine, 600 mg x 3/j, jusqu'à 600 mg x 4/j (P > 100 kg) ou pristinamycine 1g x 3 /j

  Pas d'antibiothérapie locale

- Mesures d'hygiène rigoureuses (changement de linge et toilette à l'eau et au savon tous les jours)

- Chez l'enfant : avis spécialisé (pédiatre hospitalier) car les formes compliquées abcédées sont plus fréquentes

FURONCULOSE

- Diagnostic et bilan
  - Répétition de furoncles pendant plusieurs mois, voire des années
  - Prélèvement bactériologique d'un furoncle avant traitement
  - Dépistage du portage de SA au niveau des gîtes bactériens (nez, gorge, anus, périnée) : après échec d'une première décolonisation des gîtes bactériens

FURONCULOSE

- **Traitement**
  - **Lors d'une poussée :**
    - antibiothérapie orale: clindamycine, 600 mg x 3/j, jusqu'à 600 mg x 4/j (P > 100 kg) ou pristinamycine 1g x 3 /j pendant 7 jours.
    - mesures d'hygiène et protection des lésions par pansement,
    - douches antiseptiques avec une solution moussante de chlorhexidine comme savon et comme shampoing (une fois par jour pendant 7 jours).
  - **Après guérison de la poussée :**
    - décolonisation des gîtes bactériens du patient et de son entourage (personnes vivant sous le même toit, et personnes en contact proche).

FURONCULOSE

Protocole de décolonisation

- Application nasale de pommade de mupirocine deux fois par jour pendant 7 jours
- Utilisation une fois par jour pendant 7 jours d'une solution moussante de chlorhexidine comme savon et comme shampoing
- Mesures d'hygiène corporelle, porter des vêtements propres, changer fréquemment le linge de toilette, non partage du linge
- Bains de bouche biquotidiens à la chlorhexidine (adulte et enfant à partir de 6 ans)

ABCES CUTANES

Les abcès cutanés primaires sont le plus souvent dus à *S. aureus* .

- Prélèvement bactériologique du pus de l'abcès
- **Traitement**
  - Incision/drainage

  ET
  - Antibiothérapie pendant **5 jours**
    - **Clindamycine** PO/IV*: 600 mg x 3/j, jusqu'à 600 mg x 4/j (P > 100 kg)
    - **Pristinamycine** 1g x 3 /j ou
    - **Oxacilline ou cloxacilline** IV* : 6 à 12 g/jour ou
    - **Céfazoline** IV* : 3 à 6 g/ jour

    * non adapté au traitement en ambulatoire



- Renforcement des mesures d'hygiène

ABCES CUTANES



Commentaires du groupe des référentiels de la SPILF

La voie IV n’est pas adaptée à un traitement en ambulatoire.

La cloxacilline ne doit pas être utilisée par voie orale.

Des doses de béta-lactamines moins élevées peuvent être utilisées pour traiter ce type d’infection.

IMPETIGO

- Principalement dû à *S. aureus*, et parfois au *S. pyogenes*.
- **Clinique** :
  - Formes communes :
    - vésiculo-pustuleuse et secondairement croûteuse
    - bulleuse surtout chez les enfants < 2 ans
  - Formes graves
    - Ecthyma (forme nécrotique creusante)
    - Surface cutanée atteinte > 2 % de la surface corporelle totale chez l'adulte et 1% chez l'enfant (= surface d'une paume de la main)
    - Nombre de lésions > 6
    - Extension **rapide** des lésions

IMPETIGO

- **Bilan**
  - **Forme localisée** ou peu étendue : pas de prélèvement bactériologique
  - **Forme grave** : prélèvement bactériologique des lésions actives (pus, liquide de bulle).
- **Principale complication =** glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique
  - exceptionnelle en France métropolitaine
  - sa recherche systématique dans les suites d'un impétigo n'est pas recommandée

IMPETIGO SIMPLE

- **Traitement**
  - **Soins de toilette** quotidiens ou biquotidiens, avec nettoyage à l'eau et au savon suivi d'un rinçage soigneux
  - Pas d'application d'antiseptiques locaux
  - Antibiothérapie locale par mupirocine : 3 fois/j durant 5 j
- **Éviction de collectivité :** 3 jours après le début du traitement, si lésions non protégées par pansement.

TRAITEMENT DE L'IMPETIGO GRAVE

- Antibiothérapie orale durant 7 jours, sans attendre les résultats du prélèvement bactériologique

Adulte	Pristinamycine per os : 1 g x 3 /j ou Céfalexine per os : 2 à 4 g/j A réévaluer en fonction des résultats des prélèvements bactériologiques
Enfant	Amoxicilline/acide clavulanique : 80 mg/kg/j ou Céfadroxil : 100 mg/kg/j Allergie aux bétalactamines: josamycine 50 mg/kg/j A réévaluer en fonction des résultats des prélèvements bactériologiques

TRAITEMENT DE L'IMPETIGO GRAVE

Mesures complémentaires:

- Applications biquotidiennes de vaseline (après les soins de toilette)
- Pas d'antibiothérapie locale.
- Pas de nécessité de prendre en compte le SARM pour le traitement probabiliste de première intention d'un impétigo

Annexe

Définition du syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS)

- **Hypotension** (pression systolique ≤90 mmHg chez l'adulte ou <5ième percentile pour l'âge chez l'enfant de moins de 16 ans)

ET

- **Défaillance multi-viscérale** caractérisée par au moins 2 des anomalies suivantes :
  - **insuffisance rénale**: chez l'adulte, créatinine ≥ 177 micromol/L; chez l'enfant, ≥2 fois la limite supérieure de la normale pour l'âge; chez les patients avec une atteinte rénale préexistante, élévation ≥2 fois la valeur de base,
  - **coagulopathie**: plaquettes ≤100,000/mm^3 ou coagulation inrra-vasculaire disséminée (définie par un temps de coagulation allongé, un taux de fibrinogène bas et la présence de produits de dégradation de la fibrine,
  - **atteinte hépatique**: taux d'ALAT, ASAT, ou de bilirubine totale ≥2 fois la limite supérieure de la normale pour l'âge du patient; chez les patients avec une atteinte hépatique préexistante, élévation ≥2 fois la valeur de base,
  - **syndrome de détresse respiratoire aiguë**,
  - **éruption maculaire érythémateuse disséminée**, pouvant évoluer vers la desquamation
  - **nécrose des tissus mous** (fasciite ou myosite nécrosante, gangrène).

SCTS probable si les critères ci-dessus sont présents et un SGA est isolé d'un site **non stérile** (gorge, vagin, lésion cutanée).

SCTS certain si les critères ci-dessus sont présents **et** un SGA est isolé d'un site normalement **stérile** (sang, liquide cérébro-spinal, liquide articulaire, liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal, biopsie tissulaire, ou plaie chirurgicale).